



[EPIC] Nova Messagerie

 Évolution de Weda Échange vers une messagerie sécurisée de santé intégrée, intelligente et transparente au sein du LGC Weda.

 Epic généré avec Claude Opus 4.6 le 10/04/2026.

Le prompt complet est consultable dans la section repliable "Prompt utilisé" ci-dessous

▼ Prompt utilisé

Prompt 1 > Tu es un product manager senior qui travaille chez Weda, leader du LGC en mode SaaS en France. A partir du contexte décrit dans le fichier prompt-epic-messagerie.md de ce projet, génère un epic dans un fichier epic.md. Cet epic devra cadrer la vision de NOVA Messagerie pour que les architectes, PM, product designers et développeurs puissent la mettre en oeuvre dans le développement d'un produit.

Prompt 2 > Très bien ! Je veux une petite modification dans l'epic produit :

Dans le JTBD 1, section capacités attendues, le classement automatique dans le dossier patient par analyse du contenu doit aussi pouvoir se faire par la fonctionnalité "reconnaissance automatique de documents", qui analyse le contenu textuel d'un document pour en extraire des métadonnées telles que les informations administratives du patient (nom, prénom, date de naissance, sexe, etc...).

Contenu de prompt-epic-messagerie.md

Definition

Weda est un logiciel de gestion de cabinet (LGC) à destination des médecins libéraux, auxiliaires de santé et sages-femmes qui exercent en France.

Disposer d'une messagerie sécurisée de santé (système MSSanté) intégrée au logiciel de gestion de cabinet, pour envoyer et recevoir des informations médicales nécessaires à la coordination du parcours de soin des patients est un pré-requis fondamental au travail des cabinets médicaux utilisateurs de Weda.

Weda dispose d'une intégration de MSSanté, via son système Weda Echange.

Je veux que tu génères un epic qui va décrire la solution "NOVA Messagerie". Cette solution est l'évolution de Weda Echange pour les utilisateurs de Weda qui sont des professionnels de santé, mais aussi des secrétaires et des coordinateurs. Voici les grands principes de vision pour NOVA Messagerie :

* La collaboration avec les professionnels de santé et mes patients se fait de manière naturelle et transparente, intégrée au sein de mes flux de travail durant mes consultations, mais également en dehors de mes consultations.

* La messagerie doit être vue comme une commodité pour l'utilisateur, il n'a pas à réfléchir comment les messages vont être reçus et envoyés. L'utilisateur doit pouvoir intégrer dans Weda différentes boîtes aux lettres personnelles mais aussi organisationnelles (boîte propre au cabinet plutôt qu'à un individu).

* L'utilisateur n'a pas besoin de connaître ni de saisir les adresses email de ses correspondants, l'intégration de l'annuaire national MSSanté couplée à l'annuaire RPPS permet de trouver très simplement un correspondant.

Jobs to be done :

Recevoir des documents médicaux de la part d'autres professionnels de santé

Pour permettre à l'utilisateur de NOVA Messagerie une prise en charge coordonnée des soins de ses patients. La réception ne doit pas se matérialiser par une simple liste de travail à partir des messages reçus.

NOVA Messagerie doit être capable de contextualiser et de prioriser l'information, pour aider le professionnel de santé à traiter en priorité les informations importantes : sévérité des informations médicales reçues. Le cadre d'interop des systèmes d'information de santé (CI-SIS) permet une structuration et une codification des informations transmises, selon des nomenclatures standardisées. L'utilisation de fonctionnalités IA de type LLM sur les données reçues est un enabler pour aller plus loin dans l'analyse de données.

Le classement des messages dans les dossiers patient doit être automatique.

Pour prendre connaissance d'un message, l'utilisateur a trois options :

- Consulter à l'avance la liste de ses messages reçus.
- A l'ouverture d'un dossier patient, pendant ou en dehors d'une consultation, le LGC met en évidence les nouveaux documents reçus.
- Etre alerté à tout moment si un message reçu comporte une urgence élevée qui nécessite une prise en compte immédiate.

Transmettre des documents médicaux à d'autres professionnels de santé

Toujours pour permettre à l'utilisateur une prise en charge coordonnée des soins de ses patients. Tout document médical produit dans le LGC Weda doit être partageable via messagerie à d'autres professionnels de santé, et au patient via Mon Espace Santé. L'envoi doit s'intégrer de la manière la plus transparente possible dans le flux de consultation.

1. Contexte & problème

Les professionnels de santé libéraux (médecins, auxiliaires, sages-femmes) et leur personnel de coordination (secrétaires, coordinateurs) ont besoin d'échanger quotidiennement des documents médicaux avec d'autres professionnels et avec leurs patients. Aujourd'hui, Weda propose **Weda Échange**, une intégration MSSanté qui remplit ce rôle mais présente plusieurs limites :

- **Expérience fragmentée** : la messagerie fonctionne comme un module séparé du flux de consultation. L'utilisateur doit quitter son contexte de travail pour consulter et traiter ses messages.
- **Classement manuel** : les documents reçus doivent être triés et rattachés manuellement aux dossiers patients, ce qui est chronophage et source d'erreurs.
- **Absence de priorisation** : tous les messages sont présentés à plat, sans distinction de sévérité ni de contexte clinique. Une lettre de liaison urgente est noyée parmi les courriers administratifs.
- **Recherche de correspondants fastidieuse** : l'utilisateur doit connaître ou rechercher manuellement les adresses MSSanté de ses correspondants.
- **Pas de vision organisationnelle** : la messagerie est exclusivement individuelle, sans possibilité de gérer des boîtes partagées au niveau d'un cabinet ou d'une structure.

Ces frictions réduisent l'adoption de la messagerie sécurisée et ralentissent la coordination des parcours de soins.

2. Vision

NOVA Messagerie transforme la messagerie sécurisée en une commodité invisible et intelligente, tissée dans chaque interaction du professionnel de santé avec son logiciel.

L'utilisateur ne "va" plus consulter sa messagerie : l'information pertinente vient à lui, au bon moment, dans le bon contexte. Envoyer un document à un confrère ou au patient est aussi naturel que l'enregistrer dans le dossier. La messagerie disparaît en tant qu'outil distinct pour devenir un flux intégré au quotidien clinique.

Principes directeurs

1. **Transparence** — L'utilisateur n'a pas à se soucier des mécanismes de routage, de protocole MSSanté ou d'adressage. Il collabore, le système achemine.
2. **Contextualisation** — Chaque message est automatiquement rattaché au patient concerné et présenté dans le contexte clinique adéquat.
3. **Priorisation intelligente** — L'information médicale est analysée, classée par sévérité et mise en évidence selon l'urgence clinique.
4. **Multi-persona** — La solution s'adresse aussi bien aux praticiens qu'aux secrétaires et coordinateurs, avec des vues et permissions adaptées à chaque rôle.
5. **Multi-boîtes** — L'utilisateur gère ses boîtes personnelles et les boîtes organisationnelles de son cabinet au sein d'une interface unifiée.

3. Personas cibles

	≡ Persona	≡ Contexte d'usage	≡ Besoin principal
1	Dr. Sophie — Médecin généraliste	En consultation (flux tendu, 15–20 min/patient) et hors consultation (revue de correspondances)	Voir immédiatement les résultats et courriers importants à l'ouverture du dossier patient, envoyer un courrier à un confrère en 2 clics
2	Marie — Secrétaire médicale	Gestion quotidienne du cabinet, tri du courrier entrant, préparation des consultations	Traiter la boîte organisationnelle du cabinet, pré-classer les documents, alerter le médecin sur les urgences
3	Thomas — Coordinateur de soins	Suivi de parcours complexes (ALD, CPTS)	Suivre les échanges pluridisciplinaires autour d'un patient, s'assurer que les documents ont été reçus et lus
4	Patient (via Mon Espace Santé)	Réception de documents depuis son praticien	Recevoir ses ordonnances, résultats et comptes-rendus de manière sécurisée

4. Jobs to be done

JTBD 1 — Recevoir et traiter les documents médicaux entrants

Quand je reçois des documents médicaux d'autres professionnels de santé, **je veux** que ces documents soient automatiquement classés dans le dossier du bon patient, priorisés par sévérité clinique et présentés dans mon flux de travail, **afin de** traiter en priorité les informations urgentes sans effort de tri manuel.

Capacités attendues :

- Classement automatique dans le dossier patient par analyse du contenu (identité patient, IPP, INS) et par **reconnaissance automatique de documents** : analyse du contenu textuel des documents reçus pour en extraire les métadonnées administratives du patient (nom, prénom, date de naissance, sexe, etc.) permettant le rattachement au bon dossier même en l'absence d'identifiants structurés.
- Priorisation des messages par sévérité clinique, en exploitant les métadonnées structurées du CI-SIS et une couche d'analyse IA (LLM) pour les contenus non structurés.
- Trois modes de prise de connaissance :
 - **Revue proactive** : consultation de la liste des messages reçus, filtrée et triée par priorité.
 - **Contextuel au dossier** : à l'ouverture d'un dossier patient (en consultation ou hors consultation), mise en évidence visuelle des nouveaux documents reçus.
 - **Alerte temps réel** : notification immédiate en cas de message à urgence élevée nécessitant une action rapide, quel que soit l'écran en cours.

JTBD 2 — Transmettre des documents médicaux à d'autres professionnels de santé et au patient

Quand je produis un document médical dans Weda (ordonnance, compte-rendu, lettre de liaison...), **je veux** pouvoir le partager à un confrère ou au patient via Mon Espace Santé de manière fluide et intégrée à mon flux de consultation, **afin de** assurer la continuité et la coordination du parcours de soin sans rupture dans mon activité.

Capacités attendues :

- Tout document produit dans le LGC est partageable en un geste (bouton contextuel "Envoyer via messagerie" / "Transmettre au patient").
- Recherche de correspondants intégrée : l'annuaire national MSSanté couplé à l'annuaire RPPS permet de trouver un destinataire par nom, spécialité ou localisation — sans saisir d'adresse email.
- Envoi vers Mon Espace Santé du patient en un clic depuis le dossier.
- Gestion des favoris et correspondants fréquents pour accélérer les envois récurrents.
- Suivi de l'acheminement (envoyé, reçu, lu si supporté par le protocole).

JTBD 3 — Gérer des boîtes aux lettres personnelles et organisationnelles

Quand je travaille dans un cabinet avec plusieurs praticiens et du personnel de coordination, **je veux** pouvoir accéder à ma boîte personnelle ainsi qu'à une ou plusieurs boîtes organisationnelles partagées, **afin de** garantir la continuité du traitement des messages même en cas d'absence d'un membre de l'équipe.

Capacités attendues :

- Intégration de boîtes MSSanté personnelles (rattachées au RPPS du praticien) et organisationnelles (rattachées à la structure/FINESS).
- Vue unifiée ou séparée selon la préférence utilisateur.
- Gestion des droits d'accès par rôle (praticien, secrétaire, coordinateur) sur les boîtes organisationnelles.
- Possibilité de déléguer le traitement d'un message à un autre membre du cabinet.

JTBD 4 — Trouver un correspondant sans friction

Quand je dois contacter un professionnel de santé que je ne connais pas personnellement, **je veux** le retrouver rapidement par son nom, sa spécialité ou sa localisation, sans avoir à connaître son adresse MSSanté, **afin de** ne jamais être bloqué dans mon besoin de coordination.

Capacités attendues :

- Annuaire intégré MSSanté + RPPS avec recherche multi-critères (nom, spécialité, ville, établissement).

- Auto-complétion et suggestions contextuelles (correspondants du patient, derniers contacts, cercle de soins).
- Carnet d'adresses personnel et partagé au niveau du cabinet.

5. Fonctionnalités clés (Feature map)

	≡ #	≡ Feature	≡ JTBD	≡ Priorité	≡ Complexité estimée
1	F1	Boîte de réception unifiée avec vue multi-boîtes (perso + orga)	JTBD 3	Must-have	Élevée
2	F2	Classement automatique des messages entrants dans les dossiers patients (INS, CI-SIS)	JTBD 1	Must-have	Élevée
3	F3	Priorisation et scoring de sévérité des messages (métadonnées CI-SIS + IA/LLM)	JTBD 1	Must-have	Élevée
4	F4	Widget "nouveaux documents" dans le dossier patient	JTBD 1	Must-have	Moyenne
5	F5	Alertes temps réel pour messages à urgence élevée	JTBD 1	Should-have	Moyenne
6	F6	Envoi contextuel depuis tout document Weda (ordonnance, CR, lettre...)	JTBD 2	Must-have	Moyenne
7	F7	Envoi vers Mon Espace Santé (DMP/MES)	JTBD 2	Must-have	Moyenne
8	F8	Annuaire intégré MSSanté + RPPS avec recherche multi-critères	JTBD 4	Must-have	Moyenne
9	F9	Carnet d'adresses personnel et organisationnel (favoris, fréquents)	JTBD 4	Should-have	Faible

10	F10	Gestion des rôles et permissions sur les boîtes organisationnelles	JTBD 3	Must-have	Moyenne
11	F11	Suivi d'acheminement des messages envoyés	JTBD 2	Should-have	Faible
12	F12	Délégation de traitement d'un message à un collègue	JTBD 3	Nice-to-have	Moyenne
13	F13	Analyse IA du contenu des messages pour enrichissement et résumé	JTBD 1	Nice-to-have	Élevée

6. Contraintes & dépendances

Réglementaire & interopérabilité

- **MSSanté** : conformité au référentiel de l'ANS pour l'échange de messages sécurisés entre professionnels de santé.
- **CI-SIS** : respect du Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé pour la structuration et la codification des documents échangés.
- **INS / RPPS** : identification des patients (INS) et des professionnels (RPPS) selon les référentiels nationaux.
- **Mon Espace Santé / DMP** : respect des spécifications d'alimentation du DMP et d'envoi vers Mon Espace Santé.
- **Ségur du Numérique** : alignement avec les exigences de conformité Ségur vague 2.
- **RGPD / HDS** : hébergement et traitement des données de santé sur infrastructure certifiée HDS.

Techniques

- Dépendance sur les API MSSanté (IMAP/SMTP sécurisé ou API REST selon évolution du référentiel).
- Dépendance sur l'API annuaire RPPS/MSSanté de l'ANS.
- Intégration au moteur de dossier patient Weda existant (matching INS).
- Infrastructure IA/LLM pour l'analyse de contenu (priorisation, résumé) — nécessite une évaluation d'architecture spécifique (on-premise vs cloud HDS).

Organisationnelles

- Migration progressive depuis Weda Échange : coexistence temporaire des deux systèmes nécessaire.
- Accompagnement au changement pour les utilisateurs habitués à Weda Échange.

7. Métriques de succès

	≡ Métrique	≡ Cible	≡ Méthode de mesure
1	Taux de classement automatique correct	≥ 90 % des messages classés sans intervention manuelle	Ratio messages auto-classés / total messages reçus
2	Temps moyen d'envoi d'un document	< 15 secondes depuis la production du document	Instrumentation UX (time-to-send)
3	Taux d'adoption NOVA Messagerie vs. Weda Échange	80 % des utilisateurs migrés à 6 mois post-lancement	Analytics d'usage
4	Satisfaction utilisateur (CSAT)	≥ 4.2 / 5	Enquête in-app trimestrielle
5	Taux de messages urgents traités dans l'heure	≥ 70 %	Logs d'ouverture des messages flaggés urgents
6	Nombre de boîtes organisationnelles configurées	+50 % vs. baseline Weda Échange à 6 mois	Compteur en base

8. Hors périmètre (explicitement exclu de cet epic)

- Messagerie instantanée (chat temps réel) entre professionnels — fait l'objet d'un epic séparé si validé.
- Téléconsultation et visioconférence intégrée.
- Gestion documentaire avancée (GED) au-delà du classement dans le dossier patient.
- Prise de rendez-vous ou agenda partagé.
- Facturation des actes liés aux échanges.

9. Risques identifiés

	≡ Risque	≡ Impact	≡ Probabilité	≡ Mitigation
1	Qualité du classement automatique insuffisante (INS non renseigné, documents non structurés)	Élevé	Moyenne	Fallback vers classement assisté avec suggestion + validation manuelle ; amélioration continue du modèle
2	Latence des API annuaire ANS (RPPS/MSSanté)	Moyen	Moyenne	Cache local de l'annuaire avec synchronisation périodique
3	Résistance au changement des utilisateurs	Moyen	Élevée	Migration progressive, coexistence temporaire, formation et accompagnement dédié

4	Contraintes réglementaires IA sur données de santé	Élevé	Moyenne	Veille réglementaire active, architecture IA compatible HDS, possibilité de désactiver les features IA
5	Évolution du référentiel MSSanté en cours d'implémentation	Moyen	Faible	Couche d'abstraction protocolaire, suivi des roadmaps ANS

10. Jalons indicatifs

	≡ Phase	≡ Périmètre	≡ Horizon indicatif
1	Phase 1 — Fondations	Boîte de réception unifiée (F1), classement auto (F2), envoi contextuel (F6), annuaire intégré (F8), gestion rôles (F10)	T3 2026
2	Phase 2 — Intelligence	Priorisation / scoring (F3), widget dossier patient (F4), alertes urgentes (F5), envoi MES (F7)	T4 2026
3	Phase 3 — Excellence	Carnet d'adresses (F9), suivi acheminement (F11), délégation (F12), analyse IA enrichie (F13)	T1-T2 2027

11. Parties prenantes

	≡ Rôle	≡ Responsabilité dans cet epic
1	Product Manager	Priorisation du backlog, arbitrages fonctionnels, validation des critères d'acceptance
2	Product Designer	Conception des parcours utilisateurs, prototypage, tests utilisateurs
3	Architecte logiciel	Design technique, choix d'intégration MSSanté/RPPS, architecture IA
4	Tech Lead / Développeurs	Implémentation, revue technique, estimation
5	QA	Stratégie de test, validation interopérabilité CI-SIS, tests de non-régression

6	Équipe Conformité / Réglementaire	Validation conformité Ségur, RGPD, HDS
7	Support & Customer Success	Plan de migration, formation utilisateurs, collecte de feedback